Estratégia e-SUS APS: CDS, Prontuário Eletrônico e SISAB

Documento de referência técnica — resumo elaborado a partir do Manual do Sistema com Coleta de Dados Simplificada, publicado pelo Ministério da Saúde

1. O que é a Estratégia e-SUS APS

A Estratégia e-SUS APS é uma iniciativa da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) voltada a reorganizar, em escala nacional, a forma como as informações da Atenção Primária são produzidas, registradas e utilizadas. Ela integra o esforço mais amplo do Ministério da Saúde de reestruturar seus sistemas de informação, partindo da premissa de que gerir bem a informação é condição para qualificar o atendimento à população.

O nome remete ao processo de informatização qualificada do SUS — a busca por um SUS eletrônico. O objetivo é oferecer a municípios e serviços de saúde um modelo de gestão da informação que sustente tanto a administração da APS quanto o cuidado prestado ao cidadão.

1.1 Diretrizes que orientam a estratégia

- **Individualizar o registro** — cada informação de saúde é vinculada a um cidadão específico, permitindo acompanhar sua trajetória de atendimentos.
- **Integrar a informação** — unificar, sob um modelo comum, os diversos sistemas oficiais que coexistiam na Atenção Primária.
- **Reduzir o retrabalho** — evitar que o mesmo dado precise ser registrado em várias fichas ou sistemas diferentes.
- **Informatizar as unidades** — desenvolver soluções aderentes ao processo de trabalho real da APS e estimular a informatização dos serviços.
- **Apoiar a gestão do cuidado** — usar tecnologia para otimizar o trabalho das equipes na perspectiva do cuidado, não apenas do registro.
- **Favorecer a coordenação do cuidado** — qualificar o uso da informação de modo a integrar os diferentes serviços de saúde.

2. SISAB: o sistema nacional de informação

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013. É ele o sistema vigente para fins de financiamento da Atenção Primária, monitoramento e acompanhamento do cuidado, e verificação de adesão aos programas e estratégias previstos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

O SISAB não é alimentado diretamente pelos profissionais. Ele recebe os dados produzidos pelo Sistema e-SUS APS, que é a camada de coleta na ponta. Essa separação entre coleta local e consolidação nacional é central para entender o fluxo da informação na APS.

3. Os dois caminhos de coleta: CDS e PEC

O Sistema e-SUS APS reúne dois softwares de coleta, pensados para cenários distintos de informatização das Unidades Básicas de Saúde:

	Sistema com CDS	Prontuário Eletrônico e-SUS APS (PEC)
Natureza	Solução de transição e de contingência.	Prontuário eletrônico propriamente dito.
Quando se aplica	UBS sem informatização, ou com informatização ainda indisponível (queda de energia, falha de rede).	UBS informatizada, com sistema disponível para uso durante todo o atendimento.
Como o dado entra	Fichas em papel preenchidas pela equipe e posteriormente digitadas.	Registro direto no sistema, ao longo do atendimento.
Objetivo principal	Garantir que nenhum dado se perca onde ainda não há informatização.	Apoiar a informatização das UBS e a gestão do cuidado.

Os dados coletados pelo CDS são digitados no próprio CDS (que funciona off-line) ou no Prontuário Eletrônico, e de lá seguem para o SISAB por meio de uma instalação do Prontuário Eletrônico que tenha conectividade. No texto do manual, os dois softwares aparecem abreviados como CDS e PEC.

4. As fichas da Coleta de Dados Simplificada

O CDS se organiza em torno de um conjunto de fichas em papel, cada uma correspondente a um tipo de registro. As fichas de uso geral são:

- Cadastro Individual
- Cadastro Domiciliar (e Territorial)
- Atendimento Individual
- Atendimento Odontológico Individual
- Procedimentos
- Atividade Coletiva
- Visita Domiciliar e Territorial
- Marcadores de Consumo Alimentar
- Vacinação
- Vacinação Covid-19
- Síndrome Neurológica por Zika / Microcefalia (ficha complementar)

Há ainda duas fichas de uso exclusivo do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): a Ficha de Avaliação de Elegibilidade e a Ficha de Atenção Domiciliar.

Um ponto de método vale destaque: a entrada de dados segue o curso natural do atendimento, em vez de se organizar em torno de uma situação-problema de saúde. Registrar por cidadão, e não por agravo, é o que viabiliza a gestão do cuidado e aproxima os dados do planejamento da equipe.

4.1 De quem é a responsabilidade pelo registro

> **Regra importante:** a responsabilidade pelas informações é de quem realizou o cadastro, o atendimento ou o procedimento. Não cabe ao digitador — nem a qualquer outro profissional — completar campos em branco, corrigir dados ou apontar o que falta, ainda que conheça a informação. Diante de uma ficha incorreta ou incompleta, o procedimento recomendado é devolvê-la ao profissional que originou o registro.

4.2 Atualização das fichas

As fichas do CDS seguem um ciclo de revisão próprio, distinto do versionamento do software: podem ser alteradas anual ou bienalmente, conforme as necessidades apontadas pelos municípios e a pactuação tripartite. Gestores e coordenadores de Atenção Básica precisam considerar esse calendário ao planejar a produção gráfica das fichas impressas.

5. Política de controle de versões

O Sistema e-SUS APS adota um versionamento clássico no formato *major.minor.revision*, em que cada dígito sinaliza o tipo de mudança contida na versão — e, portanto, o impacto esperado da atualização:

Dígito	Tipo de alteração	Como o município deve proceder
1º (N)	Novas funcionalidades	Avaliar o que foi incluído e planejar a substituição considerando a requalificação dos profis
2º (E)	Manutenção evolutiva	Avaliar as alterações, atualizar quando viável e comunicar as melhorias à equipe.
3º (C)	Manutenção corretiva	Atualizar o quanto antes: são correções de falhas do sistema ou de bibliotecas, com impac

Na prática, identificar uma funcionalidade exige apenas os dois primeiros dígitos — "versão 2.2", por exemplo. O terceiro só importa quando é preciso apontar uma versão exata, tipicamente em chamados de suporte técnico.

6. Cadastro da Atenção Básica

6.1 Identificação pelo Cartão Nacional de Saúde

Tanto o CDS quanto o Prontuário Eletrônico identificam os registros pelo Cartão Nacional de Saúde (CNS). É essa identificação que permite coordenar o cuidado e compartilhar informações entre serviços.

> **Universalidade:** a ausência de CNS não pode impedir o atendimento. O cidadão sem cartão deve ser atendido, e o registro pode ser feito normalmente no CDS ou no Prontuário Eletrônico. A diferença é que esse registro passa a ser um dado individualizado porém não identificado, compondo apenas o consolidado de ações da equipe. No cadastro, existe a opção de marcar que o cidadão não possui CNS, e o acompanhamento segue normalmente.

6.2 Cadastro do Cidadão e Cadastro do Território

O módulo de cadastro se divide em duas frentes com propósitos diferentes:

- **Cadastro do Cidadão** — feito no Prontuário Eletrônico, dentro da UBS. É mais enxuto, contém apenas informações individuais e pode interoperar com a base nacional do CNS. Serve inclusive para usuários que não pertencem ao território da equipe.
- **Cadastro do Território** — feito pelo CDS, por meio das fichas de Cadastro Individual e de Cadastro Domiciliar e Territorial. É conduzido pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) para registrar os moradores de suas microáreas. É bem mais extenso e reúne informações-chave sobre a população sob responsabilidade da equipe.

Apesar de serem caminhos distintos, os dados convergem. Um cadastro feito em ficha e digitado no CDS fica disponível na base local do Prontuário Eletrônico, acessível pelo módulo "Cidadão". No sentido inverso, se o cidadão já havia sido cadastrado no Prontuário e depois é cadastrado pelo ACS, a digitação no CDS aproveita os dados de identificação existentes, desde que haja o CNS para fazer a correspondência.

> A consulta à base nacional do CNS depende de conexão de internet disponível na UBS.

6.3 Interoperabilidade com o CadSUS

A Portaria GM/MS nº 2.073, de 31 de agosto de 2011, regulamentou o uso de padrões de interoperabilidade e de informação em saúde para sistemas nos âmbitos municipal, distrital, estadual e federal, alcançando também o setor privado e a saúde suplementar. A partir dela, o Ministério da Saúde, com apoio do DataSUS, vem ampliando a integração entre os sistemas de apoio à assistência.

No caso específico do cadastro do cidadão, organizado pelo Sistema Cartão Nacional de Saúde, o Catálogo de Padrões de Interoperabilidade de Informações de Sistemas de Saúde (CPIISS) define dois perfis IHE:

- **PIX** (Patient Identifier Cross-referencing, HL7 V3) — permite que aplicações distintas reconheçam que registros identificados por códigos diferentes se referem ao mesmo paciente.
- **PDQ** (Patient Demographics Query, HL7 V3) — permite consultar dados demográficos em um servidor central; no Brasil, o Cadastro Nacional de Usuários do SUS.

Ambos os perfis já constam do barramento do Cartão Nacional de Saúde mantido pelo DataSUS e estão integrados ao Sistema e-SUS APS.

7. Fluxo do cidadão e acolhimento à demanda espontânea

As ferramentas do e-SUS APS que organizam o percurso do cidadão na unidade — como a Lista de Atendimento e a Agenda — foram desenhadas a partir do Caderno de Atenção Básica (CAB) nº 28, que trata do acolhimento à demanda espontânea.

O modelo parte do pressuposto de que a recepção é o primeiro contato, e de que situações imprevistas exigem um espaço adequado de escuta, análise e definição da oferta de cuidado. Três premissas sustentam o desenho:

- Usuários com atividade agendada ou de rotina — uma consulta marcada, uma vacina — devem ser recebidos e direcionados sem espera desnecessária.
- Situações imprevistas fazem parte da rotina e requerem organização prévia da unidade e do processo de trabalho para serem compreendidas e resolvidas.
- Quem realiza a escuta inicial precisa saber identificar risco e vulnerabilidade, conhecer as ofertas de cuidado da UBS, ter canal de diálogo com colegas e respaldo para acionar essas ofertas conforme a necessidade.

A estratificação entre casos agudos (atendimento imediato, prioritário ou no dia) e não agudos (intervenções programadas) busca fazer com que a necessidade do usuário determine o tipo e o tempo da intervenção — materializando o princípio da equidade. Em alguns casos, o próprio profissional da escuta inicial já pode intervir, dentro dos protocolos locais.

> O fluxograma deve ser lido como ponto de partida, não como regra absoluta. Aplicá-lo sem ajuste à realidade de cada serviço tende a gerar mais problemas do que resolve.

8. Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP 2)

Na Atenção Primária, o diagnóstico etiológico frequentemente não é o dado mais relevante. A CIAP, hoje em sua segunda versão, organiza-se a partir da pessoa e de seu contexto social, e não da doença. Na ficha de registro ambulatorial do CDS, é a CIAP 2 que identifica os Problemas Avaliados.

Isso importa porque um problema de saúde raramente se reduz a um diagnóstico: pode ser um sintoma, uma queixa, uma incapacidade, um medo, ou a necessidade de um cuidado específico — uma imunização, por exemplo.

A estrutura tem dois eixos: 17 capítulos, organizados por sistema ou área, e 7 componentes comuns a todos eles.

Capítulos

Cód.	Capítulo	Cód.	Capítulo
A	Geral e não específico	R	Aparelho respiratório
B	Sangue e órgãos hematopoiéticos	S	Pele
D	Aparelho digestivo	T	Endócrino, metabólico e nutricional
F	Olhos	U	Aparelho urinário
H	Ouvidos	W	Gravidez e planejamento familiar

Cód.	Capítulo	Cód.	Capítulo
K	Aparelho circulatório	X	Aparelho genital feminino
L	Sistema musculoesquelético	Y	Aparelho genital masculino
N	Sistema nervoso	Z	Problemas sociais
P	Psicológico		

Componentes (válidos para todos os capítulos)

Nº	Componente
1	Queixas e sintomas
2	Procedimentos diagnósticos e preventivos
3	Medicações, tratamentos e procedimentos terapêuticos
4	Resultados de exames
5	Administrativo
6	Acompanhamento e outros motivos de consulta
7	Diagnósticos e doenças (infecciosas, neoplasias, lesões, anomalias congênitas e outras)

Fonte e licença

Este documento é um resumo de referência elaborado a partir do Capítulo 1 do Manual do Sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS), publicado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde e disponível em sisaps.saude.gov.br/sistemas/esusaps/docs/manual/CDS/.

O conteúdo foi reescrito e reorganizado; não se trata de reprodução do texto original. Os manuais do e-SUS APS são disponibilizados sob licença Creative Commons Atribuição–NãoComercial–CompartilhaIgual 4.0 Internacional.

Para uso normativo, operacional ou de referência oficial, consulte sempre o manual completo na fonte indicada. As fichas do CDS e as versões do sistema são revisadas periodicamente.